# TEMA 9 · Bioética, inteligencia artificial, secreto profesional y protección de datos. Sistemas de información y registros

Resumen OPE Enfermería SMS · Bloque A: Principios bioéticos, CEA, IA, secreto profesional, Código Deontológico, RGPD y LOPDGDD · Bloque B: OMI-AP, SELENE, Ágora Plus, registros, informe al alta, CMBD, CIE-10-ES y NANDA-NOC-NIC

## A1. Principios de la bioética

- **Potter** acuñó el término "bioética" (años 70): puente entre ciencias biológicas y humanidades.
- **Informe Belmont (1978)**, tras el experimento de **Tuskegee**: **3 principios**: respeto a las personas (→ consentimiento informado), beneficencia y justicia.
- **Beauchamp y Childress (1979)**: **4 principios** *prima facie* (sin jerarquía): **autonomía**, **beneficencia**, **no maleficencia** y **justicia**.

| Principio | Claves |
|---|---|
| **Autonomía** | Decisión libre, informada y sin coacción; se materializa en el **consentimiento informado** |
| **Beneficencia** | Hacer el bien, promover el bienestar; sin autonomía deriva en **paternalismo** |
| **No maleficencia** | *Primum non nocere*: **evitar el daño**; base de la **seguridad del paciente** (checklist, "correctos", asepsia) |
| **Justicia** | Equidad y distribución de recursos (triaje, trasplantes, listas de espera) |

- **Diego Gracia** los jerarquiza: **ética de mínimos** (nivel público, exigible: **no maleficencia y justicia**) por encima de la **ética de máximos** (nivel privado: **autonomía y beneficencia**).

**TRAMPAS DE EXAMEN**

! La división en mínimos y máximos es de **Diego Gracia**, no de Beauchamp y Childress.

! Prevenir eventos adversos = **no maleficencia**, no beneficencia.

## A2. Deliberación, Comités de Ética Asistencial e instrucciones previas

- **Dilema ético**: conflicto de valores en el que cualquier decisión lesiona alguno.
- **Método deliberativo (Diego Gracia)**: presentación del caso → hechos clínicos → problemas éticos → problema principal → valores en conflicto → cursos de acción (**extremos** e **intermedios**) → curso óptimo → **pruebas de consistencia: legalidad, publicidad y tiempo**.
- **CEA en Murcia: Decreto 66/2005, de 10 de junio**. Los crean hospitales o gerencias, con **acreditación de la Consejería**. Composición interdisciplinar: medicina y enfermería, **al menos un jurista**, **al menos un lego** y formación en bioética.
  - Funciones: **consultiva** (informes **no vinculantes**), **normativa** (protocolos) y **docente**.
  - **No pueden**: evaluar **ensayos clínicos** (eso es del **CEIm**), mediar en conflictos laborales, tramitar quejas o reclamaciones patrimoniales, ni juzgar faltas.
- **Instrucciones previas (art. 11 Ley 41/2002)**: no se aplican si son contrarias al ordenamiento o a la lex artis o no corresponden al supuesto previsto; representante; registro autonómico conectado al **Registro Nacional**. Ante conflicto con la familia, **prevalecen las instrucciones previas**.

## A3. Inteligencia artificial en sanidad

- Retos: **sesgo de automatización**, opacidad (**caja negra**), **sesgos algorítmicos** (vulneran la justicia), privacidad, responsabilidad legal y deshumanización.
- **Principios de la OMS (2021)** (6): proteger la **autonomía humana**, promover el bienestar y la seguridad, **transparencia y explicabilidad**, **responsabilidad y rendición de cuentas**, **inclusividad y equidad**, y IA **sensible**

**y sostenible**.

- **Reglamento europeo de IA (AI Act)**: enfoque por riesgo; la mayoría de la IA sanitaria (monitorización predictiva, triaje, dosificación) es de **alto riesgo**: evaluación de conformidad, gestión de riesgos, datos de calidad, registros, documentación, ciberseguridad y **supervisión humana**.
- **Espacio Europeo de Datos de Salud**: **uso primario** = asistencia directa (también transfronteriza); **uso secundario** = investigación, estadística y entrenamiento de IA con datos anonimizados.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! Seguir ciegamente una alerta errónea de la IA **no exime** de responsabilidad: el juicio clínico no se delega.

## A4. Secreto profesional

- Deber ético, deontológico y legal de reserva sobre toda la información del paciente. Modalidades: **absoluto** (insostenible), **relativo** (vigente: admite excepciones), **compartido** (equipo asistencial) y **derivado** (personal no sanitario).
- **CE art. 18.1** (intimidad) y **18.4** (límites a la informática). **Ley 41/2002**: art. 7 (intimidad), art. 16 (uso de la historia para docencia o investigación con **datos disociados**) y art. 19 (custodia).
- **Código Penal**: particulares, art. 197; **profesional sanitario, art. 199.2**: **prisión de 1 a 4 años**, multa de 12 a 24 meses e **inhabilitación especial de 2 a 6 años**.
- **Excepciones**: consentimiento del paciente, **EDO**, **mandato judicial** (solo lo pertinente), daño grave e inminente a terceros, sospecha de **delitos y malos tratos** y protección del propio paciente.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! Los hijos de un paciente **capaz** no tienen derecho a su información sin su autorización.

## A5. Código Deontológico de la Enfermería Española

- Aprobado por el **Consejo General de Enfermería** mediante la **Resolución 32/89** (sustituyó al código de 1954). Es de obligado cumplimiento para los colegiados; su incumplimiento lo sancionan los **colegios** (con independencia de la vía civil o penal).

| Artículo | Contenido |
|---|---|
| **4** | No discriminación |
| **5** | Proteger la dignidad del paciente |
| **9** | Nunca usar ni consentir la fuerza física o moral para obtener el consentimiento |
| **19** | **Secreto profesional** |
| **20** | Advertir de los límites del secreto; no aceptar secretos que dañen a terceros |
| **22** | **Objeción de conciencia** |
| **38** | **Emergencias**: si es la más cualificada, decide; en catástrofes, se pone a disposición |
| **39** | Gestión: relación dialogante; **nunca reprender en público** |
| **42** | Protección de la infancia |
| **56-57** | Responsabilidad individual de sus actos |

- **Renovación en curso** (Comisión Deontológica Nacional): ética digital e IA, teleenfermería, final de la vida (LORE), genética y reproducción.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! **La objeción de conciencia nunca ampara negar la atención en una urgencia vital.**

## A6. RGPD (Reglamento UE 2016/679)

- Es un **reglamento**: **aplicación directa** sin transposición (las directivas sí la necesitan).
- **Principios (art. 5)**: licitud, lealtad y transparencia; **limitación de la finalidad**; **minimización** (acceder solo a lo necesario: curiosear historias la vulnera); exactitud; limitación del plazo de conservación; integridad y confidencialidad; y **responsabilidad proactiva** (demostrar el cumplimiento).
- **Consentimiento (arts. 6-7)**: **libre, específico, informado e inequívoco** (acción afirmativa). Prohibidas las casillas premarcadas y el silencio. Retirarlo debe ser **tan fácil como darlo**.
- **Categorías especiales (art. 9)**: salud, genéticos, biométricos, origen étnico, ideología, religión, afiliación sindical, vida u orientación sexual. **Prohibido su tratamiento** salvo excepciones (art. 9.2): consentimiento explícito, **intereses vitales** (paciente inconsciente), **asistencia sanitaria** por profesional sujeto a secreto y **salud pública**.

## A7. LOPDGDD (LO 3/2018, de 5 de diciembre)

- Deroga la LOPD de 1999 y añade los derechos digitales.
- **Art. 3 · fallecidos**: familiares, personas vinculadas y herederos pueden acceder a sus datos, salvo **prohibición expresa del fallecido** o de la ley.
- **Art. 5**: deber de **confidencialidad** de todos los que traten datos, que **se mantiene tras terminar la relación**.
- **Art. 7 · menores**: consienten el tratamiento de sus datos **los mayores de 14 años**; por debajo, los titulares de la patria potestad.
- **Art. 9**: el solo consentimiento no basta para tratar datos con el fin principal de identificar ideología, religión, orientación sexual u origen étnico.
- **Derechos (arts. 13-18)**: **acceso** (salvo anotaciones subjetivas y datos de terceros), **rectificación**, **supresión** ("derecho al olvido", muy limitado por la obligación de conservar la historia), **limitación**, **portabilidad** y **oposición**.
- **Delegado de Protección de Datos (art. 34)**: obligatorio en los centros sanitarios que mantienen historias clínicas, **salvo los profesionales que ejercen a título individual**. Enlace con la **AEPD**.

> **TRAMPAS DE EXAMEN**
>
> ! **14 años = consentimiento para datos (LOPDGDD). 16 años = consentimiento clínico (Ley 41/2002).**
>
> ! La "A" de ARCO es **acceso**.

# BLOQUE B · Sistemas de información y registros de enfermería

## B1. Historia clínica digital y aplicativos del SMS

- Seguridad de la información: **confidencialidad, integridad, disponibilidad y no repudio** (trazabilidad con huella electrónica o *log*).
- **Historia clínica (Ley 41/2002)**: su fin **principal es la asistencia**; docencia, investigación, calidad y gestión son fines secundarios. La **custodia** es de la institución; el paciente es **titular de los datos**, pero no puede exigir borrar diagnósticos válidos.
- Registro enfermero: **objetivo**, preciso, **simultáneo** y trazable.
- Interoperabilidad: **HCDSNS** (estatal) y **MyHealth@EU** (europeo): **Patient Summary** y **receta electrónica europea**.

| Aplicativo | Uso |
|---|---|
| **OMI-AP** | **Atención Primaria**: episodios de atención, carpeta familiar, condicionantes de salud, programas, receta, agendas |
| **SELENE** | **Atención Especializada**: gestión de camas y traslados, hospitalización (gráfica, balance, administración de medicación), quirófano, críticos, consultas externas y urgencias |
| **Ágora Plus** | **Visor regional** que integra la información de todos los niveles (informes, analíticas, imagen PACS) |

**TRAMPAS DE EXAMEN**

! Gestionar camas o traslados = **SELENE**. Ver desde el centro de salud la analítica del hospital = **Ágora Plus**.

## B2. Registros específicos de enfermería y escalas

| Escala | Valora | Claves |
|---|---|---|
| **Barthel** | ABVD | 0-100: < 20 total; 21-60 grave; 61-90 moderada; 91-99 leve; 100 independiente |
| **Katz** | ABVD | Letras **A a G**; 6 funciones |
| **Lawton y Brody** | AIVD | Máximo **8** puntos |
| **Pfeiffer** | Cognición | 10 ítems; cuenta **errores**: 0-2 normal; 3-4 leve; 5-7 moderado; 8-10 severo |
| **MEC de Lobo** | Cognición | Sospecha de deterioro < 24 (< 20 en ancianos) |
| **Zarit** | Sobrecarga del cuidador | ≤ 46 no; 47-55 leve; 56-88 intensa |
| **Norton** | Riesgo de UPP | 5-20; **≤ 12 alto riesgo** |
| **Braden** | Riesgo de UPP | 6-23; **≤ 12 alto**; 13-14 moderado; 15-18 bajo |
| **Downton / Morse** | Riesgo de caídas | Downton **≥ 3**; Morse **> 45** |
| **Maddox / VIP** | Flebitis | 0-5 |
| **EVA / FLACC** | Dolor (5.ª constante) | FLACC en pediatría |

- **Atención domiciliaria**: registrar barreras arquitectónicas, vivienda, adaptaciones y red de apoyo.
- **Pérdidas insensibles** = **peso (kg) × horas / 2** (0,5 ml/kg/h). Fiebre: añadir 0,1 ml/kg/h por grado > 37 °C (unos 150 ml/día por grado). Taquipnea: +1 ml/h por cada respiración > 20 rpm.

**TRAMPAS DE EXAMEN**

! En Pfeiffer, **más puntos = más deterioro** (cuenta errores).

## B3. Informe de cuidados de enfermería al alta (RD 1093/2010)

- **RD 1093/2010, de 3 de septiembre**: conjunto mínimo de datos de los informes clínicos del SNS. Las CC. AA. pueden añadir variables, no quitarlas.
- Anexos: I alta médica, II consulta externa, III urgencias... **VII informe de cuidados de enfermería**.
- Variables **CM** (conjunto mínimo, obligatorias) y **R** (recomendadas).

| Bloque | Contenido |
|---|---|
| **1. Documento y paciente** | CM: tipo de documento, fechas, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, sexo y profesional. R: contacto, DNI, NASS |
| **2. Valoración al alta (todo CM)** | Alergias, constantes, estado cognitivo y sensorial, integridad cutánea, autonomía, dispositivos |
| **3. Metodología** | **Diagnósticos (NANDA) = CM**; **intervenciones (NIC) y resultados (NOC) = R** |
| **4. Entorno** | Cuidador principal (R) |

**TRAMPAS DE EXAMEN**

! Sin códigos NIC o NOC el informe **sigue siendo válido**; sin diagnósticos NANDA, no.

## B4. CMBD y clasificaciones

- **RAE-CMBD (RD 69/2015)**: hospitalización, CMA, hospitales de día, urgencias y procedimientos complejos ambulatorios. Variables demográficas, del episodio y clínicas (**diagnóstico principal**, secundarios y procedimientos).

En Murcia lo gestiona **SIVA-CMBD** (centros públicos y **privados**).

- **CIE-10-ES**: obligatoria desde el **1 de enero de 2016** (sustituye a la CIE-9-MC).
  - **Diagnósticos**: **3 a 7 caracteres** (letra + 2 números; punto decimal; "X" de relleno; 7.º carácter en traumatología). Volúmenes: lista tabular, instrucciones e índice alfabético; **21 capítulos**.
  - **Procedimientos (PCS)**: **siempre 7 caracteres**, sin punto: sección, sistema orgánico, operación raíz, localización, **abordaje**, dispositivo (Z = ninguno) y calificador. No usa las letras O ni I.
- **CIAP-2 (WONCA)**: codificación en **Atención Primaria** (OMI-AP); biaxial: **17 capítulos** (letras) y **7 componentes**; permite codificar **motivos de consulta**.

| | NANDA-I 2024-2026 | NOC 7.ª ed. (2024) | NIC 8.ª ed. (2024) |
|---|---|---|---|
| **Qué es** | Diagnósticos | Resultados | Intervenciones |
| **Dominios** | **13** | **7** | **7** |
| **Número** | **277** | **612** | **614** (más de 13.500 actividades) |
| **Medición** | — | **Escala Likert 1-5** | — |

- NANDA: **135 focalizados en el problema**, **110 de riesgo** y **32 de promoción de la salud** ("Disposición para mejorar..."). NOC: 7 dominios (salud funcional, fisiológica, psicosocial, conocimiento y conducta, percibida, familiar y comunitaria). NIC: intervención (etiqueta) frente a **actividades** (se eligen las pertinentes).

**TRAMPAS DE EXAMEN**

! RD 1093/2010 = **informes clínicos**. RD 69/2015 = **RAE-CMBD**.

! Un diagnóstico de riesgo **no** lleva "manifestado por".

! **13-7-7**: dominios de NANDA, NOC y NIC.